# Kolagenózy v praxi: diagnostické a terapeutické výzvy pri systémových autoimunitných ochoreniach

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026




Ilustračná scéna. Prekryvy medzi jednotkami sú pravidlom – a práve preto je diagnóza aj liečba v praxi náročná.

Streamed Up v sérii **RheumaLive** venovanej téme **„Kollagenosen 2026“** zdôrazňuje, že ide o skupinu chorôb s výrazne odlišnými klinickými prejavmi, pri ktorých musia diagnostické aj terapeutické rozhodnutia zohľadňovať postihnutie orgánov a individuálnu dynamiku ochorenia. Článok sa sústreďuje na klinické otázky: ako pristupovať k podozreniu na kolagenózu, ako rýchlo zachytiť orgánové ohrozenie a ako nastaviť liečbu primerane riziku.

## 1) Čo sú kolagenózy a prečo sú náročné

Kolagenózy sú **systémové autoimunitné ochorenia**, pri ktorých imunitný systém postihuje viaceré orgánové systémy naraz alebo sa postihnutie vyvíja postupne. Aj preto sa diagnóza často oneskoruje: symptómy môžu na prvý pohľad pôsobiť nesúvisiace (napríklad koža, kĺby, pľúca, obličky, svaly, nervový systém).

Aj pri moderných imunologických metódach platí, že:

- prezentácia môže byť nešpecifická alebo „prekrývajúca sa“ (overlap),
- biologická aktivita sa nemusí dokonale zhodovať so subjektívnymi ťažkosťami pacienta,
- a orgánové komplikácie môžu nastúpiť rýchlo.

Systémovo treba uvažovať už od prvého kontaktu a diagnostický plán nastaviť tak, aby včas pokryl aj „najhoršie scenáre“.

## 2) Prvý krok: klinická mapa rizík

V praxi je užitočné rozdeliť anamnézu a vyšetrenie do troch hlavných oblastí:

### A) Systémové symptómy a zápalová aktivita

Horúčky, chudnutie, únava, artralgie a laboratórne známky zápalu (CRP, sedimentácia) sú len vodítkom. Samy osebe diagnózu neurčia, ale naznačujú, že nejde o izolovaný problém.

### B) Orgánové varovné príznaky

Pri kolagenózach môže byť rozhodujúce, či už ide o ohrozenie orgánu. Typické príklady:

- **obličky** (napríklad proteinúria, opuchy, penivosť moču, zhoršenie renálnych parametrov),
- **svaly** (progredujúca svalová slabosť),
- **pľúca** (dyspnoe, kašeľ, intersticiálne zmeny, iné respiračné prejavy),
- a často aj **koža a sliznice** (exantém, fotosenzitivita, ulcerácie).

Pri diagnostike kolagenóz nejde len o „správny názov“, ale predovšetkým o to, či pacienta treba chrániť pred orgánovým poškodením práve teraz.

### C) Vzorec príznakov („pattern“) podľa domén

Ak sa príznaky opakujú v typických zostavách, zvyšuje sa pravdepodobnosť určitej podskupiny kolagenózy. Napríklad pri svalovej slabosti treba cielene myslieť na myozitídové spektrum.

## 3) Diagnostika: čo sa robí a prečo nestačí jeden test

Rheuma-Liga uvádza praktický a na orgány orientovaný diagnostický postup: lekár najprv zhodnotí typické symptómy, doplní laboratóriá a zobrazovanie (napríklad ultrazvuk, RTG), sleduje funkcie postihnutých orgánov a v niektorých situáciách sa pristúpi aj k mikroskopickému vyšetreniu tkaniva (napríklad k biopsii). Symptómy sa medzi jednotlivými kolagenózami líšia, a preto býva potrebný individuálny plán.

### 3.1 Laboratóriá a imunológia: protilátky ako „smerovník“

Autoprotilátky môžu diagnózu významne urýchliť. Rheuma-Liga spomína, že **antinukleárne protilátky (ANA)** sú pri kolagenózach často prítomné a bližšie určenie typu protilátok môže pomôcť rozlíšiť podskupiny. Pri niektorých entitách sa cielene vyšetrujú aj špecifické autoprotilátky (napríklad anti-dsDNA pri aktívnom SLE, prípadne anti-Ro a anti-La pri Sjögrenovom syndróme).

Pre prax z toho vyplýva:

- protilátky sú výborný nástroj, ale **nie sú náhradou kliniky**,
- a pozitívny nález bez zodpovedajúceho fenotypu vyžaduje opatrnosť, aby sa pacient zbytočne „neoznačil“.

### 3.2 Moč a obličkové ukazovatele pri podozrení na nefritídu

Pri podozrení na postihnutie obličiek sa vyšetruje moč a následne sa hodnotia známky glomerulárneho poškodenia. Rheuma-Liga uvádza, že zápal pri systémovom lupus erythematosus možno zachytiť vyšetrením moču a prvými viditeľnými varovaniami môžu byť opuchy členkov a pena v moči ako signál vysokého obsahu bielkovín.

### 3.3 Svaly: klinika plus enzýmy a zobrazenie, niekedy aj EMG a biopsia

Ak dominuje svalová slabosť, Rheuma-Liga spomína, že typické sú zvýšené svalové enzýmy; doplniť ich môže ultrazvuk, MRI, elektromyografia a v prípade potreby aj biopsia svalu. Svalová slabosť má viac príčin a kolagenózové myozitídy treba odlíšiť od infekčných, toxických či iných etiológií.

## 4) V čom je terapeutická výzva: liečiť rýchlo, ale nie naslepo

Streamed Up v popise podujatia uvádza, že sa venuje „diagnostickým a terapeutickým výzvam“ pri rôznych formách kolagenóz. Bez podrobného záznamu jednotlivých prednášok možno všeobecne zhrnúť, čo tieto výzvy v praxi typicky znamenajú:

1. **Rýchlosť rozhodnutia.** Pri orgánovo ohrozujúcich formách nie je priestor na dlhé diagnostické váhanie. Ak sú jasné známky aktivity a rizika, terapia sa zvyčajne začína podľa závažnosti, pričom diagnóza sa priebežne spresňuje.

2. **Vyváženie účinnosti a bezpečnosti.** Imunosupresia môže dramaticky zlepšiť prognózu, ale zvyšuje riziko infekcií, metabolických komplikácií a nežiaducich účinkov. Preto treba vopred myslieť na prevenciu a monitorovanie.
3. **Stratifikácia podľa orgánového postihnutia.** Univerzálna liečba neexistuje. Taktika sa mení podľa toho, či ide o kožné, kĺbové, pľúcne alebo obličkové postihnutie.
4. **Dlhodobé riadenie.** Cieľom nie je iba krátkodobá remisia, ale aj jej udržanie bez relapsu a minimalizácia kumulatívnej toxicity liečby.

## 5) Praktický diagnosticko-terapeutický rámec (čo by mal vedieť klinik)

Nasledujúci rámec je určený pre prax; nie je to presný algoritmus konkrétneho programu.

### Krok 1: Potvrdiť, že nejde o jednorazový incident

Zhodnoťte trend príznakov, zápalové parametre a to, či existujú „orgánové“ príznaky. Ak dominuje napríklad nefritída alebo myozitída, nejde o asymptomatický nález.

### Krok 2: Cieliť diagnostiku na orgány

Cieľom je odhaliť postihnutie obličiek, svalov, pľúc a iných systémov tak, aby sa liečba zbytočne neoneskorila a zodpovedala riziku. V praxi to typicky znamená:

- vyšetrenie moču pri podozrení na nefritídu,
- svalové enzýmy, zobrazovanie a doplnenie podľa potreby pri slabosti,
- a ďalšie cielené vyšetrenia podľa kliniky.

### Krok 3: Imunologická stratifikácia

Použite ANA a doplnkové protilátky na orientáciu, pričom výsledok vždy interpretujte v kontexte pacienta.

### Krok 4: Multidisciplinárne rozhodnutie

Pri aktívnom orgánovom postihnutí je často potrebná spolupráca reumatológa, nefrológa, pneumológa alebo neurológa podľa domény. Skracuje to cestu k správnej intervencii.

## 6) Čo s „nejasnými“ prípadmi

Keď je klinický obraz rozporuplný a protilátky sú hraničné alebo nešpecifické, ľahko sa urobí diagnostická chyba v oboch smeroch:

- buď sa významná aktivita podcení,
- alebo sa pacient zbytočne lieči, hoci ide o inú príčinu.

V takých prípadoch rozhoduje:

- časový priebeh,
- kvalita monitorovania (opakované hodnotenie orgánov),
- a zrozumiteľný plán, čo je ďalší krok, ak sa aktivita zhorší.

## 7) Záver

Pri kolagenózach nerozhoduje jediné laboratórne vyšetrenie, ale premyslený, orgánovo orientovaný prístup. Diagnostické a terapeutické výzvy, na ktoré upozorňuje podujatie „Kollagenosen 2026“, sa v klinike prejavujú potrebou rýchlo zachytiť orgánové ohrozenie, správne interpretovať imunologické nálezy a prispôsobiť liečbu riziku a dynamike ochorenia. Cielená diagnostika (moč, svaly, autoprotilátky, doplnenie podľa domény) a bezpečne vedená terapia umožňujú ochrániť orgány a zároveň obmedziť liečebnú záťaž.

---

***Zdroj (podujatie):*** *streamed-up.com, „Kollagenosen 2026“ (RheumaLive, 2026).* *Link na zdroj.*

***Zdroj (klinický prehľad diagnostiky kolagenóz):*** *Rheuma-Liga, „Kollagenosen“.* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kolagenozy-v-praxi-diagnosticke-a-terapeuticke-vyzvy · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.